Berufspolitisches Seminar

Ambulante Operationen

S. Sauer

Berufsverband der
COLOPROKTOLOGEN
Deutschlands e.V.

Vortrag: Ambulante Operationen

AutorIn: Dr. Sandra Sauer, Berlin [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: BeraterIn (B): Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung der Autorin / des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)

[2]: EigentümerIn (E): Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)

[3]: InvestorIn (I): Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, AnteilseignerIn etc.)

[4]: MitarbeiterIn (M): Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (MitarbeiterIn des Produktherstellers)

[5]: Produkt (P): Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)

[6]: Keine (K): Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form

Gesetzliche Aufträge zur Förderung der Ambulantisierung

§ 115b SGB V **Amb. Operieren im Krankenhaus, AOP**	**§ 115f (neu) SGB V** **Spezielle sektorengleiche Vergütung Verordnungs-ermächtigung**
Auf Grundlage eines Gutachtens Vereinbarung: • AOP Katalog (neu: stationsersetzende Behandlungen) • Einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertragsärzte	Spezielle Sektorengleiche Vergütung für bestimmte Leistungen des AOP-Kataloges, die unabhängig davon erfolgt, ob sie ambulant oder stationär erbracht werden

Hintergrund

Sektorengleiche Vergütung

Hybrid DRG-Vergütungsvereinbarung vom 18.12.2024

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)

GKV-Spitzenverband (GKV-SV)

Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)

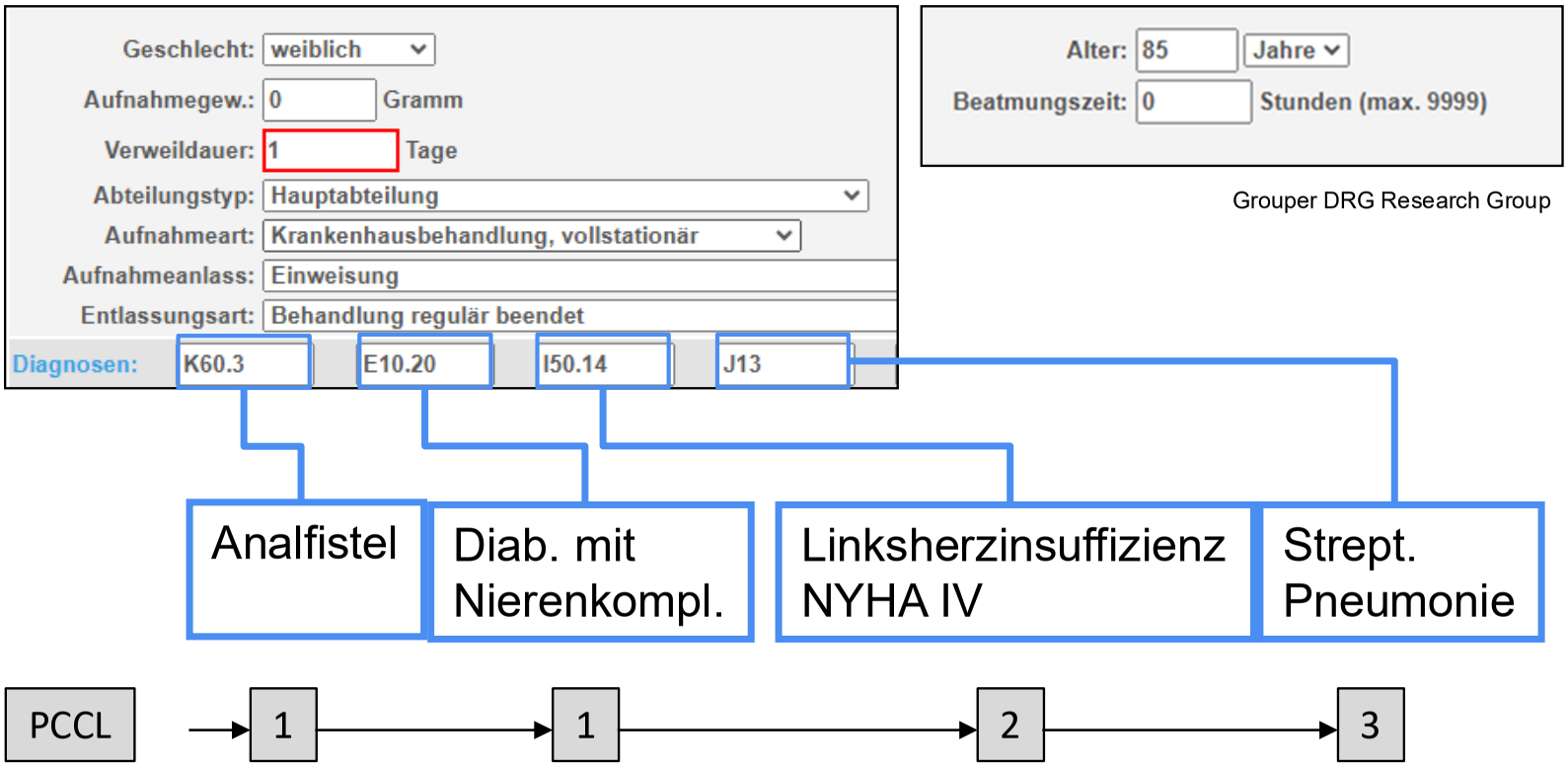
… Ersatz der Ersatzvornahme des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)

Hintergrund

Grundsätzlich nicht betroffen von Hybrid DRG

- Patienten mit Verweildauer von 2 Tagen
- Patienten mit einem PCCL 3
- Aufwendige Diagnosen wie Bösartige Neubildungen
- (Vergl. Definitionshandbuch 2025 des InEK)

Hintergrund – Exkurs PCCL



Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Gültigkeit: 01.01.2025 – 31.12.2025

Eine Hybrid DRG wird generiert:
sofern sich aus dem Definitionshandbuch ,,aG-DRG German Diagnosis Related Groups" des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus eine Zuordnung der jeweiligen Leistung zu der jeweiligen Hybrid-DRG ergibt (§ 5 Nr 1)

Es gelten die deutschen Kodierrichtlinien (§ 5, Abs 2)

In Anlage 1 zur Hybrid-DRG-Vereinbarung ist der **Leistungskatalog** mit den entsprechenden OPS-Codes aufgeführt und in Anlage 2 die entsprechende **Vergütung (Fallpauschale)** festgelegt (§ 3)

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

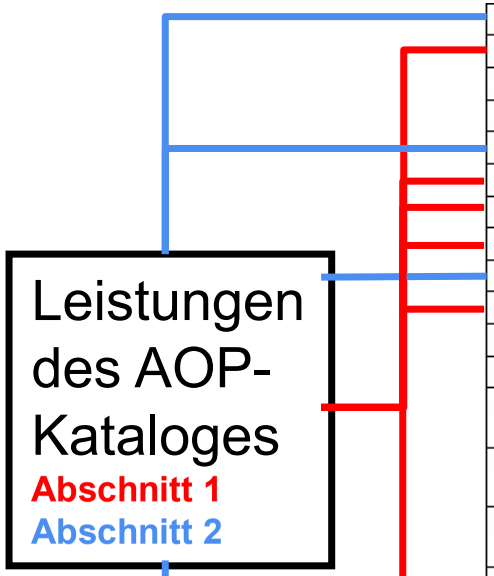
Anlage 1: 575 OPS-Codes

Anlage 2

9 Leistungsbereiche (22 Hybrid DRG (10 davon neu))

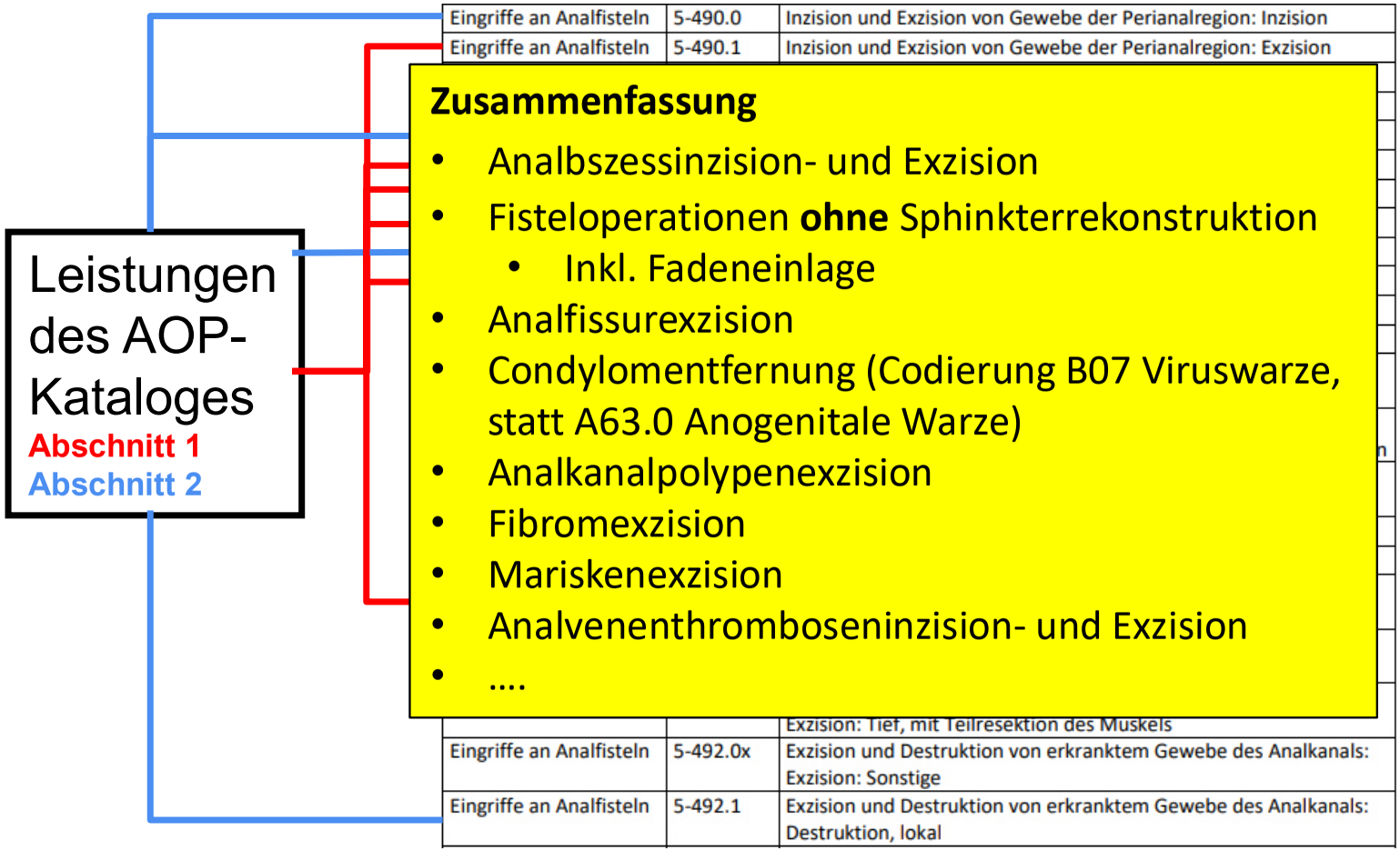
- Exzision Sinus Pilonidalis
- Eingriffe an Analfisteln
- Bestimmte Hernieneingriffe
- Ovarektomien
- Arthrodesen Zehengelenke
- Leistungsbereich Harnleitersteine
- Endoskopische Eingriffe an Galle, Leber und Pankreas
- Eingriffe an Hoden und Nebenhoden
- Lymphknotenbiopsien

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung (Anlage 1)



Eingriffe an Analfisteln	5-490.0	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
Eingriffe an Analfisteln	5-490.1	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
Eingriffe an Analfisteln	5-490.x	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige
Eingriffe an Analfisteln	5-490.y	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: N.n.bez.
Eingriffe an Analfisteln	5-491.0	Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)
Eingriffe an Analfisteln	5-491.10	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan
Eingriffe an Analfisteln	5-491.11	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär
Eingriffe an Analfisteln	5-491.12	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär
Eingriffe an Analfisteln	5-491.15	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös
Eingriffe an Analfisteln	5-491.16	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subanodermal
Eingriffe an Analfisteln	5-491.1x	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Sonstige
Eingriffe an Analfisteln	5-491.2	Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage
Eingriffe an Analfisteln	5-491.3	Operative Behandlung von Analfisteln: Verschluss von Analfisteln durch Plug-Technik
Eingriffe an Analfisteln	5-491.4	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen
Eingriffe an Analfisteln	5-491.5	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen
Eingriffe an Analfisteln	5-491.x	Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige
Eingriffe an Analfisteln	5-491.y	Operative Behandlung von Analfisteln: N.n.bez.
Eingriffe an Analfisteln	5-492.00	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal
Eingriffe an Analfisteln	5-492.01	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief
Eingriffe an Analfisteln	5-492.02	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels
Eingriffe an Analfisteln	5-492.0x	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Sonstige
Eingriffe an Analfisteln	5-492.1	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung (Anlage 1)



Eingriffe an Analfisteln	5-490.0	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
Eingriffe an Analfisteln	5-490.1	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
		Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels
Eingriffe an Analfisteln	5-492.0x	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Sonstige
Eingriffe an Analfisteln	5-492.1	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung (Anlage 1)

Leistungen Eingriffe Sinus

Leistungen des AOP-Kataloges
Abschnitt 1

Exzision eines Sinus pilonidalis	5-490.0	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-490.1	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-490.x	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-490.y	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: N.n.bez.
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-491.0	Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-491.2	Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-492.1	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-891	Inzision eines Sinus pilonidalis
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.0	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.10	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Mittelliniennaht
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.11	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Transpositionsplastik
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.12	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.1x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Sonstige
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.y	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: N.n.bez.

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung (Anlage 1)

Leistungen Eingriffe Sinus

Leistungen des AOP-Kataloges
Abschnitt 1

Exzision eines Sinus pilonidalis	5-490.0	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision

Zusammenfassung

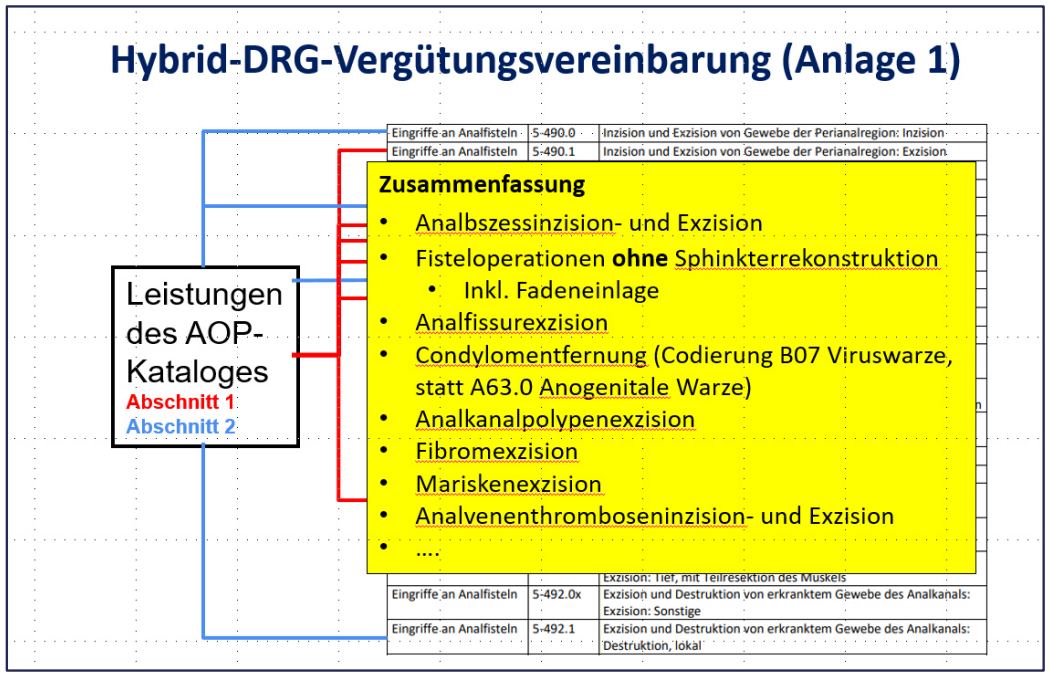
Sinus Pilonidalis Inzision

= Exzision!

= Plastische Rekonstruktion!!

Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.0	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.10	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Mittelliniennaht
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.11	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Transpositionsplastik
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.12	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.1x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Sonstige
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.x	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige
Exzision eines Sinus pilonidalis	5-897.y	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: N.n.bez.

…. Was bleibt übrig?



Stationär aDRG:

- Sphinkterrekonstruktionen

Ambulant gem. § 115b SGB V:

- Hämorrhoidenoperationen
  - Exzision
  - Staplerhämorrhoidopexie

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung (Anlage 2)

Leistungsbereich	Hybrid-DRG	Bezeichnung der Hybrid-DRG	Fallpauschale der Hybrid-DRG ohne postoperative Nachbehandlung im Krankenhaus (Spalte A) in Euro	Fallpauschale der Hybrid-DRG zuzüglich postoperativer Nachbehandlung im Krankenhaus (Spalte B) in Euro
Exzision eines Sinus pilonidalis	J09N	Hybrid-DRG der DRG J09B (Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal, Alter > 15 Jahre)	1.199,83	1.229,83
Eingriffe an Analfisteln	G26N	Hybrid-DRG der DRG G26A (Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter < 18 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit kleinem Eingriff am Rektum)	961,98	991,98
Eingriffe an Analfisteln	G26M	Hybrid-DRG der DRG G26B (Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden, Alter > 17 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne kleinen Eingriff am Rektum)	929,36	959,36

Vergütung 2024: 1038,17

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Berechtigte Leistungserbringer (§ 1)

Die an der Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer

gemäß § 95 Absatz 1 Satz 1 SGB V
Krankenhäuser nach § 108 SGB V

die die Qualitätsvoraussetzungen gem. § 115b Absatz 1 Satz 5 SGB V erfüllen.

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Zugang (§ 2 Abs 1)

Für jeden GKV Versicherten dessen Karte eingelesen ist und ein Ausweis vorgelegt wurde.

Anmerkung:

Es besteht die Möglichkeit Wahlleistung, Chefarzt abzuschließen

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Mit der Hybrid-DRG sind abgegolten (§ 4) / Gültigkeit (§ 5 Abs 3)

Beginn:
nach Abschluss der Indikationsstellung und Überprüfung der Operationsfähigkeit **mit der Einleitung der Maßnahmen zur Operationsplanung und -vorbereitung**

Gültigkeit:

Krankenhaus: Tag der Aufnahme

Vertrags*ärztinnen: Tag der Durchführung der Leistung

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Mit der Hybrid-DRG sind abgegolten (§ 4) / Gültigkeit (§ 5 Abs 3)

Ende:

mit dem Abschluss der postoperativen Nachbeobachtung in der Einrichtung, in der die Operation durchgeführt wird.

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Mit der Hybrid-DRG sind abgegolten (§ 4, § 5 Abs 7)

Postoperative Nachbehandlung innerhalb von 21 Tagen pOp

Krankenhaus:
Möglichkeit zur Abrechnung einer Fallpauschale der Hybrid DRG zuzüglich pOp Nachbehandlung mit einer um 30€ höheren Vergütung

Vertragsärzt*innen:
pOp Behandlungskomplexe gem. Einheitlichen Bewertungsmaßstab

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Mit der Hybrid-DRG sind abgegolten (§ 4, § 5 Abs 7)

Postoperative Nachbehandlung
Befundkontrolle(n),
Befundbesprechung,
Verbandwechsel,
Drainagewechsel,
Drainageentfernung,
Einleitung und/oder Kontrolle der medikamentösen Therapie.

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Mit der Hybrid-DRG sind abgegolten (§ 5 Abs 4)

Die Fallpauschale ist für die gesamte Dauer der erbrachten Leistungen nach Anlage 1 unabhängig von der Anzahl der beteiligten Leistungserbringer **nur einmal berechnungsfähig**.

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Neben der Fallpauschale darf nicht abgerechnet werden (§ 5 Abs 5):

Leistungen gemäß Anlage 1
Zusätzliche Eingriffe, sofern sich damit eine Hybrid-DRG ergibt
Aufklärung
perioperative Anästhesieleistungen
perioperative Laboruntersuchungen
histopathologische und zytologische Beurteilung
perioperative bildgebende Verfahren
postoperative Überwachung und Nachbeobachtung
Sachkosten und Arzneimittel mit Ausnahme von Sprechstundenbedarf
Kosten für Unterkunft und Verpflegung
ärztliche Abschlussuntersuchung(en)
Dokumentation(en) inkl. AU
Abschlussbericht

BERUFSVERBAND DEUTSCHER PATHOLOGINNEN UND PATHOLOGEN e.V.
BDC Berufsverband der Deutschen Chirurgie e.V.
BDA BERUFSVERBAND DEUTSCHER ANÄSTHESISTINNEN UND ANÄSTHESISTEN

Vereinbarung
zwischen
dem Berufsverband Deutscher Pathologinnen und Pathologen e.V.
(nachfolgend Pathologie genannt)
und
dem Berufsverband der Deutschen Chirurgie e.V. (BDC) und
dem Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten e.V. (BDA)
(nachfolgend Operateure genannt)
zur Honoraraufteilung im Rahmen von Hybrid-DRGs (H-DRG)

Vorbemerkung

Die Parteien stellen fest, dass die durch den Gesetzgeber eingeführten H-DRG nicht berücksichtigen, dass an der Leistungserbringung mehrere eigenwirtschaftlich tätige Partner mitwirken. Dieser Mangel in der Verordnung erfordert fallweise eine individuelle Aufteilung der Honorare zwischen Operateuren und Anästhesisten einerseits sowie zwischen Operateuren und Pathologen. Zu Ersterem haben BDC und BDA bereits eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Die jeweiligen Vereinbarungen sind nicht rechtsverbindlich und haben den Charakter eines Vorschlags.

1. Soweit im Rahmen eines H-DRG pathologische Leistungen anfallen, beauftragt die abrechnende Einheit eine Pathologie und teilt mit, dass es sich um eine Untersuchung im Rahmen eines H-DRG handelt.
2. Die Pathologie führt die erste Untersuchung zur histopathologischen und zytologischen Beurteilung von einem intraoperativ entnommenen Material durch und übermittelt das Ergebnis an die einsendende Stelle.
3. Die Pathologie stellt der einsendenden Stelle eine Rechnung basierend auf den in verschiedenen Vergütungssystematiken resultierenden Honoraren. Der Rechnungsbetrag für eine Untersuchung ist über alle H-DRGs einheitlich und beträgt 45,94 Euro je Hybrid-DRG.
4. Diese Kosten werden als Vorwegabzug aus dem Gesamthonorar der H-DRG beglichen.
5. Der Festpreis umfasst dann
   - (erste) histologische oder zytologische Untersuchung und Begutachtung eines Materials sowie
   - Auslagenersatz.

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung

Neben der Fallpauschale darf nicht abgerechnet werden (§ 5 Abs 5):

Leistungen gemäß Anlage 1
Zusätzliche Eingriffe, sofern sich damit eine Hybrid-DRG ergibt
Aufklärung
perioperative Anästhesieleistungen
perioperative Laboruntersuchungen
histopathologische und zytologische Beurteilung
perioperative bildgebende Verfahren
postoperative Überwachung und Nachbeobachtung
Sachkosten und Arzneimittel mit Ausnahme von Sprechstundenbedarf
Kosten für Unterkunft und Verpflegung
ärztliche Abschlussuntersuchung(en)
Dokumentation(en) inkl. AU
Abschlussbericht

BERUFSVERBAND DEUTSCHER PATHOLOGINNEN UND PATHOLOGEN e.V.
BDC Berufsverband der Deutschen Chirurgie e.V.
BDA BERUFSVERBAND DEUTSCHER ANÄSTHESISTINNEN UND ANÄSTHESISTEN

Vereinbarung
zwischen
dem Berufsverband Deutscher Pathologinnen und Pathologen e.V.
(nachfolgend Pathologie genannt)
und
dem Berufsverband der Deutschen Chirurgie e.V. (BDC) und
dem Berufsverband Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten e.V. (BDA)
(nachfolgend Operateure genannt)
zur Honoraraufteilung im Rahmen von Hybrid-DRGs (H-DRG)

Einheitlicher Rechnungsbetrag 45,94 Euro

„Sollte aus medizinischer Indikation eine weitere (teure) Spezialuntersuchung erforderlich sein, so muss die Pathologie dies unmittelbar mitteilen. Da sich dann meist auch die Diagnose ändert, muss im Groupersystem geprüft werden, ob dann nicht mehr auf ein H-DRG zugegriffen werden muss, sondern eine EBM-Abrechnung erfolgt. “(@BDC)

Hybrid-DRG Abrechnungsregularien

Umsetzungsvereinbarung:
GKV Spitzenverband / Verband der Privaten Krankenversicherung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft

Abrechnungsvereinbarung:
GKV-Spitzenverband und Kassenärztliche Bundesvereinigung

…….Folgt (§ 5 Nr 9):
Festlegung von Abrechnungsregularien sofern die Zuordnung einer Leistung der des Hybrid DRG-Leistungskataloges zu einer Hybrid-DRG nicht erfolgt

Hybrid-DRG Weiterentwicklungsvereinbarung

GKV-SV, KBV, DGK

- Regelung Prozess zur regelmäßigen Überprüfung und Weiterentwicklung des Leistungskatalogs und der entsprechenden Fallpauschalen
- Festlegung von Regelungen zur angemessenen Abbildung der Streuung der Sach- und Laborkosten in den Fallpauschalen

(Einleitung Hybrid DRG-Vergütungsvereinbarung)

Hybrid-DRG-V

Wahlfreiheit zwischen Hybrid DRG oder Abrechnung nach EBM??

- Hybrid-DRG-Umsetzungsvereinbarung für Krankenhäuser zw. GKV-SV und DKG vom 18.12.2024:
  - „Eine Abrechnung für die in der Anlage 1 der Hybrid-DRG-Verordnung genannten Leistungen über die Vergütungssystematik für Leistungen des Vertrages nach § 115b SGB V ist ausgeschlossen“.
  - KBV: Gesetzgeber habe dies ausdrücklich im Krankenhausstrukturgesetz ausgeschlossen

Vergütung

Exzision eines Sinus Pilonidalis (5-897.0)

AOP gem. § 115b, Abschnitt 1

Leistung (Kat. H4)	Euro-GO in € 12/2024
OP (GOP 31174)	341,19
pOp ÜW (GOP 31505)	116,59
pOp Behandlg. (GOP 31626)	39,98
Anästhesie (GOP 31824)	244,05
Zuschlag Kat H4 (GOP 31455)	114,68
Summe	**856,49**

2 Tage, PCCL 0, DRG J09B aDRG Erlös + Pflegeerlös 12/2024

2192,09€ + 253,10€

J09N Hybrid-DRG-V

1229,83€ (inkl. pOp Behandlg. im KH)

*Cave Vergleich nur Näherungs-weise auf Grund unterschiedlicher Kalkulationssystematik möglich !
AOP gem. § 115b SGB V: + Kosten Narkosegase, Sauerstoff sofern 6,25€ überschreiten, + 7% der Honorarsumme als Sachmittelpauschale

Vergütung

Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung) (5-491.0)

AOP gem. § 115b, Abschnitt 2

Leistung	Euro-GO in € 12/2024
Kleinchirg. Eingriff (GOP 02301)	15,87
Anästhesie (GOP 05330)	118,98
Summe	**134,85**

2 Tage, PCCL 0, G26B
aDRG Erlös + Pflegeerlös
12/2024

2228,16€ + 261,86€

G26M Hybrid-DRG-V

959,36€ (inkl. pOp Behandlg. im KH)

*Cave Vergleich nur Näherungs-weise auf Grund unterschiedlicher Kalkulationssystematik möglich !
AOP gem. § 115b SGB V: + Kosten Narkosegase, Sauerstoff sofern 6,25€ überschreiten, + 7% der Honorarsumme als Sachmittelpauschale

Vergütung

Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage (5-491.2)

AOP gem. § 115b: nicht enthalten

EBM:
Verzeichnis nicht gesondert berechnungsfähiger Leistungen
- Leistung ist in sonstigen Gebührenordnungspositionen enthalten

2 Tage, PCCL 0, G26B aDRG Erlös + Pflegeerlös 12/2024
2228,16€ + 261,86€

G26M Hybrid-DRG-V
959,36€ (inkl. pOp Behandlg. im KH)

Operationen in der Proktologie – Resumé

- Die „allgemeine“ operative Proktologie wird ambulant
  - ambulante Strukturen in der Niederlassung werden ausgebaut/angepasst
  - es bleibt abzuwarten, ob die Fallschwere bei amb. Ops in der Niederlassung sich ändert (PCCL kl. 3!)
- Krankenhäuser müssen ihre Strukturen hin zum ambulanten Operieren anpassen
- Im Falle einer Durchführung im stationären Setting müssen die Patienten mind. 2 Nächte bleiben
  - von der Indikation bis zur Entlassung ist die Dokumentation einer Begründung für den längeren Aufenthalt essentiell (hohe Fallhöhe!!)
  - nach Möglichkeit sollten Eingriffe durchgeführt werden, die nicht in einer Hybrid DRG münden

ABER!!

CAVE!!

?????

Überprüfung durch die Krankenkassen

§ 115f Spezielle Sektorengleiche Vergütung SGB V (Abs 3 Satz 3)

Die Prüfung der Abrechnung und der Wirtschaftlichkeit sowie der Qualität der Leistungserbringung erfolgt durch die Krankenkassen, die hiermit eine Arbeitsgemeinschaft oder den Medizinischen Dienst beauftragen können.

Anmerkung: § 115b SGB V Ambulantes Operieren am Krankenhaus unterliegt nicht der Prüfung durch den Medizinischen Dienst

Blick in die Zukunft

§ 115f Spezielle Sektorengleiche Vergütung SGB V (Abs 1 Satz 5)

GKV-SV, KBV und DKG beauftragen das InEK

bis zum 15. Mai eines jeden Kalenderjahres

erstmals bis zum 15. Mai 2025

einen Vorschlag für die Kalkulation der Vergütung differenziert nach dem Schweregrad der Fälle zu erarbeiten

in den Vorschlägen ist eine schrittweise Anpassung der Vergütungen vorzusehen

mit dem Ziel, dass bis zum Jahr 2030 die Höhe der Vergütungen der nach § 115b vereinbarten Leistungen erreicht wird!!!

Blick in die Zukunft

§ 115f Spezielle Sektorengleiche Vergütung SGB V (Abs 1a atz 1)

Spätestens zum 30. Juni 2030 sind die zu kalkulierenden Fallpauschalen auf Grundlage fallbezogener empirischer Kostendaten des ambulanten und stationären Bereichs festzulegen.

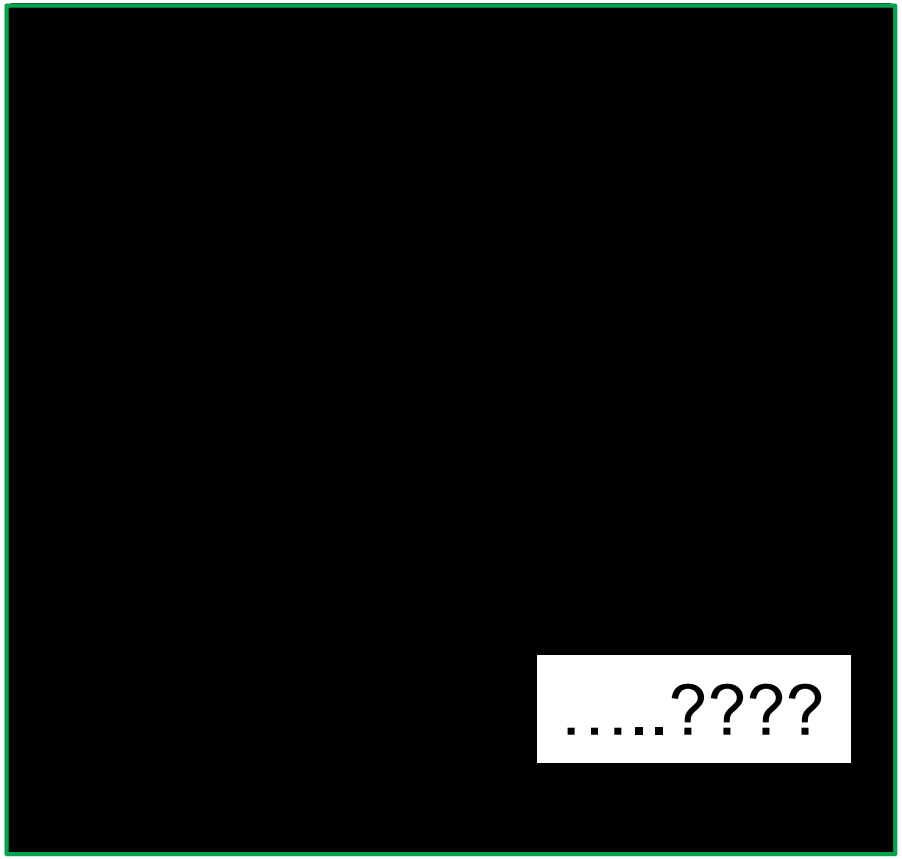
Blick in die Zukunft

§ 115f Spezielle Sektorengleiche Vergütung SGB V (Abs 5)

Das InEK wird beauftragt einen Evaluationsbericht im Abstand von jeweils 18 Monaten, erstmals zum 30. Juni 2026, vorzulegen.

Blick in die Zukunft

Blick in die Zukunft - was wird sich ändern?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!